

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA NEUROPSICOLOGÍA						
	Historia # 00004				Fecha De Impresión: 10-11-2025 18:56:59		
Datos Personales							
Nombre:	NORIS MARIA DAZA CUELLO	Sexo Biológ.:	M	F. Nacimiento:	1958-10-18	Edad	67 Años, 0 Meses, Y 23 Días
Identificación:	CC - 27003164	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Divorciado	Ocupación:	
Correo Electrónico:	Arianaraquel1989@gmail.Com - 27003164			Dirección:	Cr. 7 N 12-06 SAN JUAN		
Departamento:	LA GUAJIRA		Municipio:	RIOHACHA		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		AURELIS - Parentesco (hijo)					

Apertura Neuropsicología del 2025-06-11 18:04:55: 67 años, 0 meses, y 23 días

DATOS GENERALES

Código de consulta

No se ha seleccionado un código de consulta

Motivo de consulta

Evaluación neuropsicológica.

Enfermedad actual

Paciente con cuadro de evolución desde hace aproximadamente un mes caracterizado por ACV isquémico, momentos algo se enteró de noticia de hermana que reside en Venezuela acompañado de cefalea y evento isquémico, las secuelas se caracterizan por hemiplejia del lado derecho, síndrome de Weber, fallas en la memoria inmediata, desorientación espacial, le cuesta manejar el tiempo, fechas de cumpleaños, tono de voz bajo (posible afasia), dificultades en la deglución, no equilibrio, ataxia, restricción de la movilidad, disminución de fuerza muscular, alteraciones del estado de ánimo, comienza a mejorar la petición de necesidades, alteración del ritmo del sueño (duerme más de lo normal), alteración de la propiocepción.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

No Reporta,NO REPORTA

Traumáticos

Ninguno

Medicación

NO REPORTA

Paraclínicos

No Reporta,NO REPORTA

Hospitalizaciones

ACV Isquémico – HTA.

Patología

ACV Isquémico – HTA.

Tóxicos

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión

No Refiere

Ansiedad

No Refiere

Demencia

No Refiere

Alcoholismo

No Refiere

Drogadicción

No Refiere

Discapacidad Intelectual

No Refiere

Patológicos

NO REPORTA

Otros

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

NA

Historia laboral

NA

Historia familiar

Paciente casada – Separada, que vive con hija menor, tiene 4 hijos, relación funcional con hijos, lazos de cercanía y funcionales de relaciones sociales, cohesión en las relaciones familiares, comparte con mayoría de personas sus costumbres, cultura material, inadecuado nivel de conciencia, integración interna y relaciones con la comunidad.

Historia social

Hija refiere cambios en el estado de ánimo, prodrómicamente presenta conducta caracterizada por ansiedad, acelerada, a partir del evento se observa más callada, más relajada, poco a poco está mejorando su sentido del humor.

Historia socio-afectiva

++Dominio Conceptual: Dificultad para retener información a corto plazo (x), lenguaje fluido sin alteraciones (x), Manejo del tiempo y espacio (x), Manejo del dinero (x). [6/6] ++Dominio Social: Pocas relaciones sociales debido a la edad (+), Comunicación, lenguaje y la conversación espontánea y lógica (x), Dificultad en la regulación de las emociones y el comportamiento (

+), comprensión del riesgo en situaciones sociales (+), juicio social maduro (+), no influenciable (+). [1/6] ++Dominio Práctico: Nivel adecuado en el cuidado y aseo personal (x), autonomía en el vestirse (x), autonomía en el comer (x), no necesita ayuda en actividades de la vida cotidiana complejas en comparación con sus pares (+), No Necesita ayuda en el juicio relacionado con bienestar y organización del ocio (x). [3/6]

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

Intervención neurológica

Intervención neuropsicológica
CONSULTA

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente con adecuada presentación personal, se muestra hipoprosexica, motivada, biorritmo bajo, hiponimia, ingresa en compañía de hija, no se mantiene por si misma, restricción de la movilidad, dificultades en el lenguaje expresivo, inadecuada higiene postural, desorientada alo y orientado auto psíquicamente, lenguaje y pensamiento no fluido, fallas comprensivas, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente comprometida, quejas de memoria.

Ciclos del Sueño

NA

Apetito

NA

Actividades de Autocuidado

NA

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F019 - DEMENCIA VASCULAR, NO ESPECIFICADA

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F606 - TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANSIOSA (EVASIVA, ELUSIVA)

Impresión Diagnóstica Relacionada 2

F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Establecido por primera vez

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Según análisis clínico, criterios diagnostico CIE y evaluación de pruebas cognitivas se determina la existencia de perfil de demencia vascular no especificada, caracterizada por: 1) Desorientación alopsiquica de gravedad leve, 2) alteración de la memoria explícita a largo plazo de tipo semántica y episódica de gravedad moderada, 3) alteración en los procesos de memoria inmediata de gravedad severa, 4) calculo, 5) alteración en memoria a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal de gravedad severa, (no se evalúa el contenido visual debido a la hemiplejia reflejada en el lado derecho, no obstante esto no significa que esta función de memoria no está alterada), 6) alteración en la capacidad de aprendizaje de gravedad severa evidenciándose contaminación, omisión, 7) alteración en la fluidez verbal semántica y fonológica de gravedad severa, 8) alteración en la comprensión verbal de gravedad moderada caracterizada por perseveraciones, anomia, disfasia, 9) Inadecuada capacidad atencional – hipoprosexia, 10) dificultad en la velocidad de procesamiento, 11) alteración en los procesos ejecutivos de planificación, seguimiento de secuencia y organización, 12) control mental – memoria de trabajo, 13) praxias ideacionales e idemotoras (no se incluye en este apartado las praxias viso construccionales debido a la limitación de realizar actividades con la mano derecha, esto no quiere decir que no exista afectación). 14) agnosias, 15) dependencia de gravedad severa en actividades de la vida diaria - AVD instrumentales y de alimentación, 16) ataxia cerebelosa, (nula capacidad de coordinación y equilibrio), 17) alteración de la propiocepción, 18) cambios en conducta: Alteraciones del estado de ánimo se denota más tranquila, biorritmo bajo, más callada, antes era ansiosa, acelerada, comienza a mejorar la petición de necesidades, alteración del ritmo del sueño.

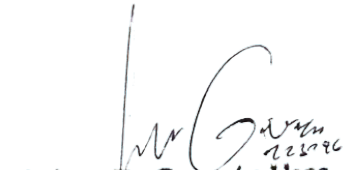
Objetivos Especificos

Consulta control por neuropsicología en tres meses. Evaluación por neuropsicología en 12 meses para determinar curso de la enfermedad. Rehabilitación por neuropsicología 2 veces por semana durante dos meses en casa que incluye: Hacer ejercicios de memoria a corto y largo plazo tipo visual y auditivo verbal, seguimiento de instrucciones de alta frecuencia, capacidad de aprendizaje, praxias, gnosias, calculo, escritura, fluidez fonológica y semántica, memoria inmediata y AVD instrumentales.

Sugerencias e Interconsultas

Observaciones y Recomendaciones

Evaluación por neuropsicología en 12 meses para determinar curso de la enfermedad.


 Jalner E. Guzmán Vega
 Psicólogo - M.G Neuropsicología
 T.P 123096
 U.S.B. - Medellín

